

قسطرة فوق العانة — وتُعرف أيضاً بأنبوب فوق العانة أو "SPT" — هي أنبوب لَين يصرف البول من المثانة عبر فتحة صغيرة في أسفل البطن، فوق عظمة العانة مباشرةً، بدلاً من المرور عبر الإحليل (مجرى البول). تشرح هذه النشرة سبب وضعها وكيفية الاستعداد وما يمكن توقعه.

عن هذا الإجراء

تُخزّن المثانة البول. حين لا يمكن تصريف البول بالطريقة المعتادة — أو يحتاج الإحليل إلى الراحة أو التجاوز — يمكن وضع قسطرة مباشرةً في المثانة عبر أسفل البطن. وبما أنها تتجاوز الإحليل، فإن أنبوب فوق العانة أكثر راحةً للاستخدام طويل الأمد وأقل أذىً للإحليل من القسطرة العادية.

قد يوصي فريقك الطبي بأنبوب فوق العانة من أجل:

- تصريف المثانة عند عدم القدرة على إفراغها بشكل ذاتي
- إراحة الإحليل أو حمايته بعد الجراحة أو الإصابة
- توفير تصريف مريح طويل الأمد (مثلاً عند وجود حالة مثانة عصبية)
- تجنب التهيج الناتج عن قسطرة الإحليل طويلة الأمد
- إتاحة النشاط الجنسي الطبيعي، و"تجارب التبول" (يمكن سدّ الأنبوب لاختبار التبول)

هل هو آمن؟

نعم. هذا إجراء شائع وآمن بشكل عام. لضمان السلامة، تُملأ المثانة حتى ترتفع نحو جدار البطن، ويستخدم الفريق عادةً الموجات فوق الصوتية و/أو كاميرا صغيرة لتوجيه الأنبوب بعيداً عن الأمعاء. معظم المشكلات — نزيف بسيط، أو إزعاج خفيف، أو تقلصات في المثانة — طفيفة وتزول سريعاً. أخبر فريقك إن كنت قد أجريت جراحة في البطن أو الحوض من قبل، إذ يستلزم ذلك عناية إضافية.

تعلم المصطلحات

فوق العانة

فوق عظمة العانة في أسفل البطن — حيث يخرج الأنبوب.

المثانة

العضو الذي يخزّن البول حتى إفراغه.

القسطرة

أنبوب لَين يصرف البول. قسطرة فوق العانة تصرّف عبر البطن بدلاً من الإحليل.

الإحليل (مجرى البول)

الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم عادةً. أنبوب فوق العانة يتجاوز.

التخدير الموضعي

دواء تخدير يُحقن في الجلد لمنع الألم في المنطقة.

التهدئة / التخدير

دواء للاسترخاء أو النوم (التخدير العام) أثناء الإجراء.

الموجات فوق الصوتية / الكاميرا

أدوات (تصوير بالموجات الصوتية أو كاميرا صغيرة في المثانة) تُستخدم لتوجيه الأنبوب بأمان.

تقلص المثانة

تشنّج مفاجئ في المثانة — شائع بعد الإجراء وقابل للعلاج.

هل سيؤلم؟ يعتمد ذلك على الأسلوب المتبع: بعض الحالات تستخدم التخدير الموضعي مع التهذنة؛ وكثيراً ما يُجرى الإجراء تحت تخدير عام أو شوكي، فتكون نائماً أو غير حاسٍ بالألم. سيُخبرك فريقك بالأسلوب المناسب. بعض التقلصات أو الألم الخفيف في الموقع بعد الإجراء أمر طبيعي. يستغرق الإجراء نحو 15-30 دقيقة.

كيف تستعدّ (قبل الإجراء)

بعد الإجراء

- يصرف البول في كيس، وسيُرشّدك فريقك إلى كيفية العناية بالأنبوب وموضع الجلد قبل المغادرة.
- ألم خفيف، أو تقلصات في المثانة، أو قليل من الدم في البول ليوم أو يومين أمر شائع.
- تغيير الأنبوب الأول يقوم به فريقك بعد نحو 4-6 أسابيع. إن سقط الأنبوب، تواصل مع فريقك فوراً — قد تنغلق القناة خلال ساعات.

- احضر بمثانة ممتلئة إن طُلب منك ذلك — يجعل الوضع أكثر أماناً. قد يطلب منك الفريق شرب الماء وحبس البول، أو قد يملؤون المثانة عند البدء.
- اتبع تعليمات الصيام — إن كنت ستتلقّى تهذنة أو تخدير عام، قد تُمنع من الأكل والشرب لساعات عدة قبله.
- رتّب وسيلة عودة إلى المنزل إن كنت ستخضع للتهذنة.

أخبر فريقك مسبقاً إذا كنت:

- قد أجريت جراحة في البطن أو الحوض — قد تغيّر الأنسجة الندبية المسار الأكثر أماناً للأنبوب
- تتناول مرقق الدم أو لديك مشكلة نزيف — غالباً ما يُوقف قبل الإجراء
- قد تكون حاملاً، أو لديك عدوى، أو حساسية من التخدير أو اللاتكس

ما الذي يحدث أثناء الإجراء

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة
- الأنبوب سقط، أو توقّف التصريف (لا بول في الكيس)
- ألم متزايد في البطن، أو تورّم، أو نزيف غزير
- بول عكر أو كريه الرائحة (علامة على عدوى)

ثلاثة أمور تذكّرها

1. قسطرة فوق العانة تصرّف مثانتك عبر فتحة صغيرة في أسفل البطن، متجاوزةً الإحليل — وهي في الغالب أكثر راحةً للتصريف طويل الأمد.
2. للاستعداد: احضر بمثانة ممتلئة إن طُلب، اتبع تعليمات الصيام، رتّب وسيلة عودة إن خضعت للتهذنة، وأخبر فريقك عن أي جراحة سابقة في البطن، أو مُرققات الدم، أو احتمال الحمل.
3. يُجرى الإجراء بتخدير موضعي وتهذنة أو تخدير عام. يُعلّمك فريقك العناية بالأنبوب ويتولى أول تغيير له بعد نحو 4-6 أسابيع. اتصل فوراً إن سقط الأنبوب، أو ارتفعت حرارتك، أو توقّف تصريف البول.

1. يُوضع المريض في الوضعية المناسبة ويُعطى التخدير — تخدير موضعي مع تهذنة، أو تخدير عام أو شوكي. ثم تُنظّف منطقة أسفل البطن وتُهيأ.
2. تُملأ المثانة بالوسائل (إن لم تكن ممتلئة بالفعل) حتى ترتفع نحو جدار البطن بعيداً عن الأمعاء.
3. بتوجيه من الموجات فوق الصوتية و/أو كاميرا صغيرة في المثانة، يُجري الفريق شقاً صغيراً فوق عظمة العانة ويدخل الأنبوب في المثانة.
4. يُنفخ بالون صغير داخل المثانة لتثبيت الأنبوب في مكانه، ثم يُوصل بكيس التصريف.